UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°2: Caso 2 - Horario 2

1.1. Información Personal:

- **Edad:** 2 años y 6 meses
- **Género:** masculino
- **Grado de instrucción:-**
- **Médicos y especialistas que lo atienden:**
  - Neurocirugía (derivación ventrículo peritoneal con controles constantes para evitar complicaciones neurológicas)
  - Urología (vejiga neurogénica, necesidad de cateterismo cada 6 horas, prevención de infecciones urinarias y daño renal)
  - Gastroenterología (botón gástrico, no líquidos vía oral. supervisión de posibles complicaciones en sistema digestivo)
  - Traumatología (escoliosis neuromuscular severa y luxación de cadera)
  - Rehabilitación (no tiene control de tronco - sedestación)
- **Procedencia:** La Victoria
- **Fuente y motivo de referencia:**
  - Referido desde el Hospital Nacional Dos de Mayo hacia el Instituto Nacional de Rehabilitación en noviembre de 2024 para mejor manejo especializado en postura y rehabilitación.
  - Aaron nació con una malformación congénita "mielomeningocele lumbar".
  - Cirugía de cierre de lesión medular al nacer.
  - Se coloca válvula ventrículo-peritoneal a los 15 días.
  - Botón gástrico a los 2 meses por dificultad para alimentarse.
  - Desarrollo psicomotor retrasado: control de cabeza al año y medio (abril 2024) no hay control de tronco y tampoco sedestación independiente.
  - Vejiga neurogénica: cateterismo cada 6 horas
  - Dificultades de coordinación motora.

Se evalúa en el INR en 2025:

- Presenta escoliosis dorsolumbar derecha severa.
- Luxación de cadera izquierda
- Se indica uso de corsé Boston Baby impide progresión de curva. (con corsé mejora grado de curvatura)

- **Regímenes de tratamiento médico o terapéutico y sus objetivos:**
  - Corsé Boston baby: evitar progresión de curva escoliótica y mejor alineación

del tronco. (uso de 23 horas diarias)
- Botón gástrico: alimentación segura (hasta los 3 años)
- Cateterismo vesical: manejo de vejiga neurogénica y prevención de infecciones urinarias (cada 6 horas).
- Lactulosa y budesonida: control digestivo y respiratorio

Controles:

- Neurocirugía: seguimiento de válvula ventrículo peritoneal
- Urología: control de vejiga neurogénica
- Gastroenterología: supervisión
- Traumatología: seguimiento escoliosis y luxación de cadera

1.2. Financiamiento:

- En relación con el financiamiento del caso, no se cuenta con información específica en la fuente. No se detalla si el paciente posee algún tipo de seguro de salud u otra cobertura que respalde diversas atenciones médicas y terapéuticas que requiera. (Se pidió información a la licenciada, no obtuvimos respuesta)
- Sabiendo que el paciente recibe atención en instituciones como el Hospital Dos de Mayo y el INR, es posible que obtenga la cobertura debido a ser paciente pediátrico con condición neurológica mediante el Seguro Integral de Salud. Este tipo de financiamiento permite el acceso a controles especializados, intervenciones quirúrgicas y seguimiento multidisciplinario.
- **Preguntas**:
- 1. ¿Los datos de la aseguradora deben ser reales o se debe presentar diversas alternativas de financiamiento? Esto dado que el caso no proporciona información.
- 2. Este apartado es para describir cómo se financia el tratamiento? o solo identificar fuentes y limitaciones?

1.3. Diagnósticos e historial médico:

- **Diagnóstico**:

  - Mielomeningocele lumbar diagnosticado al nacer, intervenido quirúrgicamente el primer día de vida. Actualmente en estado postquirúrgico con secuelas neurológicas y ortopédicas.
    - Escoliosis neuromuscular dorsolumbar severa (Cobb 68° sin corsé, 52.5° con corsé)
    - Vejiga neurogénica (manejo con cateterismo cada 6 horas)
    - Luxación de cadera izquierda
    - Estrabismo
    - Paraplejía flácida con ausencia de reflejos osteotendinosos patelar y aquíleo

- **Cirugías pasadas, planes quirúrgicos futuros:**

  - Corrección de mielomeningocele al nacer
  - Derivación ventrículo peritoneal con dos cambios posteriores
  - Colocación de botón gástrico
  - NO HAY CIRUGÍAS PROGRAMADAS SEGÚN TRAUMATOLOGÍA

- **Medicamentos:**

  - Lactulosa

- Budesonida

- **Dolor, molestias, quejas o inquietudes:**

  - Irritabilidad
  - Limitación para abducción de caderas

- **Función motora oral para el habla y la deglución:**

  - Alteración en la deglución dado que no tolera líquidos
  - Lenguaje expresivo: llama a su madre
  - Lenguaje comprensivo: responde a órdenes simples

- **Estado cardíaco y respiratorio, resistencia:**

  - **Neumonía:** último episodio en octubre 2025

- **Función intestinal y vesical:** Orina por cateterismo cada 6 horas

  - Deposición diaria

1.4. Estado psicosocial:

- Presenta irritabilidad y pobre colaboración durante la evaluación
- Logra mantener contacto visual con las personas
- Reconoce la ausencia de su madre, mostrando vínculo afectivo
- Su comunicación e interacción social son limitadas
- Depende completamente de sus cuidadores
- La familia tiene un rol fundamental en su cuidado diario

1.5. Estado neuromuscular y musculoesquelético:

- Presenta paraplejía flácida y ausencia de reflejos
- No logra controlar el tronco ni mantenerse sentado
- Evidencia retraso en su desarrollo motor
- Presenta escoliosis severa que afecta su postura
- Tiene luxación de cadera izquierda y limitación de movimiento
- Su estabilidad postural está comprometida
- Depende de otros para movilizarse y realizar actividades

1.6. Afección de la piel:

1.6.1. Afección de la piel, cicatrices, textura de los tejidos blandos, edema, color, palidez:

- Cicatrices: Presenta una cicatriz media lumbar.
- Textura de los tejidos: ¿Cuál es el estado actual de los tejidos blandos?, ¿El corsé deja algún tipo de lesión en la piel del paciente?, ¿Presenta algún tipo de palidez, coloración o edema en la piel?

1.6.2. Antecedentes o presencia de úlceras por presión, ubicación, causas desencadenantes, circunstancias circundantes, tratamiento, riesgos:

- Riesgos: úlceras por presión, dermatitis, atrofia muscular, la presión que ejerce el corsé se puede desplazar a las caderas, restricción pulmonar. [3]
- ¿El paciente ha presentado enrojecimiento en zonas de presión por el corsé?

1.7. Función sensorial/ Habla, lenguaje y comunicación:

1.7.1. Visión: visión funcional, agudeza, percepción visual

- Logra establecer contacto visual, presenta estrabismo.

1.7.2. Audición:

- ¿Se han realizado pruebas de tamizaje auditivo o se sospecha de alguna alteración en la audición del paciente?

1.7.3. percepción sensorial: tacto, propiocepción, sentido kinestésico

- Presenta paraplejía flácida y ausencia de reflejos osteotendinosos.
- ¿Cómo responde el paciente ante estímulos táctiles, dolorosos o térmicos, en especial en las extremidades inferiores?

1.7.4. Habla, lenguaje y comunicación:

- Primeras palabras al año
- **Capacidad de lenguaje expresivo y receptivo:**
  - Expresivo: llama a su madre.
  - Receptivo: Comprendió su nombre a los 7 meses, nota ausencia de madre, logra ordenes simples al año y 3 meses.
- **Habla, articulación**
  - ¿El paciente presenta dificultad al articular palabras o debilidad en la musculatura orofacial debido a su alteración en la deglución?
- **Nivel cognitivo, capacidad de aprendizaje, capacidad de atención, estado académico/educativo**
- **Uso y experiencia con dispositivos generadores de habla**
  - ¿El paciente ha usado o usa actualmente dispositivos de apoyo al habla?
  - Se irrita fácilmente, pero es capaz de seguir órdenes simples.
  - ¿Se ha realizado una evaluación cognitiva acorde a su edad?
- **Uso y experiencia con dispositivos generadores de habla**
  - ¿El paciente ha usado o usa actualmente dispositivos de apoyo al habla?

1.8. Desempeño funcional, de habilidades y de tareas:

- **Cantidad de asistencia necesaria, uso de equipos:**

  - Requiere asistencia total para el control postural, ya que no presenta control de tronco ni logra sedestación independiente.
  - Uso de corsé Boston baby (23 horas del dia)
  - Uso de botón gástrico para alimentación.

- **Actividades de la vida diaria (AVD):**
  - Depende de sus padres para todas sus actividades diarias; el caso no da más detalles.

- **Alimentación; posicionamiento para comer:**
  - Alimentación mediante botón gástrico.

- No tolera líquidos por vía oral.
-No se especifica la posición en la que es alimentado.

- **Tareas y habilidades:**
  -Por su edad y condición no realiza actividades del hogar ni similares; no se menciona habilidades específicas.

- **Actividades de mesa, medidas y apoyo:**
  -No se reporta uso de mesa, superficie de trabajo o de apoyo

1.9. Movilidad personal:

- **Ambulación:**
  - No deambula debido a la paraplejía flácida

- **Traslados:**
  - Requiere asistencia para los traslados.
  - No se especifica el tipo de traslado ni el apoyo necesario.
- **Uso de silla de ruedas**:

  -El paciente acude en silla de ruedas.
  -No se especifica el tiempo de uso diario de la silla de ruedas.
  - No se encuentra información sobre horas de uso, tolerancia a la sedestación ni tipo de silla.

1.10. Transporte comunitario:

- El paciente utiliza silla de ruedas como principal medio de movilidad. Debido a la ausencia de control de tronco, presenta una alta dependencia para su traslado.
- No se cuenta con información específica sobre el tipo de transporte que utiliza (público o privado), ni sobre las condiciones en las que realiza sus desplazamientos o las dificultades que enfrenta durante el traslado, por lo que se requiere complementar esta información.

1.11. Entornos:

- El paciente procede de La Victoria, y se desenvuelve en un entorno que, debido a su condición física, debería contar con adaptaciones que faciliten su movilidad y cuidado.
- Sin embargo, no se dispone de información detallada sobre las características del hogar, la presencia de barreras físicas ni el nivel de adecuación del entorno, por lo que se requiere información adicional para completar este análisis.

1.12. Historial de equipos anteriores:

-Hubo indicios de nuevas tecnologías o intenciones de probar alguna alternativa nueva , pero a costa de precios altos o poca desconfianza , recurrieron a opciones accesibles y disponibles por el Instituto Nacional de Rehabilitación.

1.13. Equipo actual:

- Derivación ventriculoperitoneal

  -Derivaciónventrirculo peritoneal pudenz o tipo pudenz presion baja neonatal (con código MM-539 y 20201963) [3]

  - Cateter Peritoneal >60cm, diámetro interno 1.0 o 1.2 mm, diámetro externo 2.1 mm con indicadores distanciados cada 10cm desde la punta.
  - 1 Cateter Ventricular 10 a 25 cm, diámetro interno 1.2 mm, diámetro externo 2.1 mm.
  - 4 líneas de 8 agujeros cada uno; 1 clip de ángulo recto.
  - 1 introductor de acero inoxidable grado quirúrgico,
  - Cada unidad está en bolsa termoplástica.
  - Todos los componentes deben de estar por separado.
  - Reservorio plano 20 min de largo x 11 mm ancho y 4 min de alto (válvula).

  -Procedimiento para tratar la hidrocefalia a causa de la mielomeningocele lumbar, se escogió este procedimiento esta tecnología por ser la más accesible.

  -La vida útil del dispositivo varía pues depende 100% de la válvula y su funcionamiento correcto por eso que va entre 2 años a más.

- Corsé Boston baby:

  -TLSO – Scoliosis Brace (dispositivos del mismo hospital con digo serie de propio essalud) con un estilo simple de color celeste y azul .

  -necesito datos

  -Se escogió está tecnología para corregir la escoliosis de 68° que presentaba el paciente.

  -El paciente lleva usándolo desde el 1-04-2026 , con un buen estado del dispositivo ortopédico..

  -Según estos datos , existe una gran mejora en el paciente con su escoliosis con posibles mejoras a futuro :

TABLA 1
Datos de la escoliosis con y sin corsé

Condición Hiba	Cobb °	Ángulo dorsal	Ángulo lumbosacro (ALS)	Ángulo de Ferguson (AF)	Ángulo de cifosis máx.
Sin corsé (frontal)	68°	35°	63.8°	46°	41°

Sin corsé (perfil)	—	35°	63.8°	46°	41°
Con corsé (frontal)	52.5°	—	—	—	—
Con corsé (perfil)	—	36°	70°	52°	—

- Botón gástrico

  -Botón gástrico de 16 ft (365 del listado de materiales de Essalud) [3]

  -Tiene diversas características como las siguientes:

  - Soporte externo con diseño de bajo perfil
  - Extremo distal integrado con punta y balón para llenado
  - Soporte interno con balón de retención interna de silicona
  - Válvula antirreflujo próxima'
  - Mecanismo conector del juego de extensión "Secur-Lok"
  - Marcas de longitud del ostoma y tamaño de sonda con línea radiopaca
  - Set de extensión libre de DEHP
  - Tubo de alimentación de bajo perfil
  - Juego de extensión con conector en ángulo recto Secur-Lok, con bifurcación en "Y" de dos puertos y abrazadera
  - de 12 pulgadas/30cm de longitud
  - Juego de extensión para bolo con punta de catéter, conector recto Secur-Lok y abrazadera de 12 pulgadas/30cm de longitud
  - Jeringa de 5 a 10m1
  - Jeringa de 30-50cm, con punta de catéter.
  - Longitud de Ostoma: 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.7, 2, 2.5

  -Paciente aún no tolera líquidos por vía oral, para solucionar aquello usará un botón gástrico hasta los 3 años.

  -Vida útil restante de unos 6 meses con un estado correcto del dispositivo.

2. <u>Resumen de la información del paciente/caso</u>

2.1. Usuario/Paciente: Describe las habilidades y capacidades de la persona con discapacidad

- Paciente masculino de 2 años y 6 meses con diagnóstico de mielomeningocele lumbar, que presenta paraplejía flácida, ausencia de control de tronco y dependencia total para la movilidad. Tiene limitaciones en la sedestación, alteraciones en la deglución y requiere alimentación mediante botón gástrico. Presenta además escoliosis neuromuscular severa y luxación de cadera izquierda, lo que afecta significativamente su desarrollo motor y funcional.

2.2. Actividad: Describe el conjunto de tareas a realizar por la persona con discapacidad

- Aaron lleva terapia física para fortalecer su tronco y prevenir la progresión de la escoliosis. Hace uso del corsé 23 horas diarias y logra comunicación básica con sus cuidadores.
- Conforme avance su desarrollo y se logren mejoras Aaron podría asistir a educación inicial adaptada y participar en actividades escolares con apoyo físico y pedagógico. De esta manera desarrollará habilidades comunicativas para mejor integración con diversas personas.

2.3. Contexto: Describe el entorno o contexto social, cultural y físico que rodea el entorno en el que debe realizarse la actividad.

- Vive en La Victoria, Lima, entorno familiar que lo acompaña activamente en controles médicos. En el Instituto Nacional de Rehabilitación recibe atención multidisciplinaria.
- En su día a día hace uso de una silla de ruedas junto con un corsé ortopédico, y su entorno social se basa en dependencia económica y la necesidad de cuidados constantes. Tiene acceso a servicios especializados en el INR.

2.4. Tecnología: dispositivos o estrategias utilizadas para cerrar la brecha entre las

capacidades de la persona y las demandas del entorno

- El paciente utiliza diversas tecnologías de asistencia para compensar sus limitaciones funcionales. Entre ellas se encuentran el corsé Boston Baby para el control de la escoliosis, el botón gástrico para la alimentación segura y la derivación ventriculoperitoneal para el manejo de la hidrocefalia. Asimismo, requiere el uso de silla de ruedas para su movilidad. Estas tecnologías permiten mejorar su calidad de vida y facilitar su interacción con el entorno.

Referencias:

[1] Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI). Sistema de derivación ventrículo peritoneal tipo Pudenz presión baja neonatal. Código MM-539.

[2]Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI). Kit de gastrostomia de botón de bajo perfil. 2014.

[3] Ocronos Revista Médica y de Enfermería, «Uso de corsés ortopédicos», *Ocronos - Editorial Científico-Técnica*, 8 de octubre de 2024. https://revistamedica.com/uso-corses-ortopedicos-actualidad/#Limitaciones-y-riesgos-del-uso-de-corses-ortopedicos